Processo nº 0896973-88.2024.8.10.0001

Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: ANTONIO MACEDO CARDOSO

REU: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado do(a) REU: DAVID AZULAY - RJ176637

SENTENÇA

Trata-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposto por ANTONIO MACEDO CARDOSO em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A.

Afirma a parte autora que é usuária do plano de saúde contratado junto à parte requerida e foi diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática (CID-10: J84.1), cujo tratamento é realizado por meio das medicações Nintedanibe 150 mg (1 cápsula a cada 12 horas) ou Pirfenidona 267 mg (3 cápsulas a cada 8 horas).

Contudo, o plano negou o fornecimento da medicação ao fundamento de que não estaria inserida no rol da ANS.

Diante disso, ingressou com o pedido de tutela, para que a parte requerida forneça o medicamento, além de indenização por danos morais.

Concedida a justiça gratuita, a tutela de urgência e determinada a realização de audiência de conciliação.

A parte requerida apresentou contestação, alegando que o fornecimento do medicamento para uso domiciliar está fora do previsto na legislação de saúde suplementar, motivo pelo qual não há defeito na prestação do serviço e tampouco danos morais a serem indenizados. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido inicial. Juntou documentos.

Petição da parte requerida informando a interposição de agravo de instrumento.

Realizada audiência de conciliação, as partes não transigiram.

A parte autora apresentou réplica.

Intimadas quanto à produção de outras provas, as partes nada requereram.

É o que importa relatar.

Ante a argumentação apresentada pelas partes, passo ao julgamento do feito.

Consta na inicial que a parte autora é usuária do plano de saúde contratado junto à parte requerida e que e foi diagnosticada com diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática (CID-10: J84.1), cujo tratamento é realizado por meio das medicações Nintedanibe 150 mg (1 cápsula a cada 12 horas) ou Pirfenidona 267 mg (3 cápsulas a cada 8 horas).

Contudo, o plano negou o fornecimento da medicação ao fundamento de que não estaria inserida no rol da ANS e tampouco prevista dentro da legislação de saúde suplementar.

Não assiste razão à parte requerida.

É cediço que a Lei 9.656/98 regula a atuação dos planos de saúde em âmbito nacional, com manifestação expressa de aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos elaborados entre as operadoras e seus usuários (artigo 35-G), de modo que deverá ser integralmente aplicado, como forma de facilitação dos direitos do usuário, conforme disposição do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Inclusive, a matéria foi objeto da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, onde se lê que "*aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*".

Em que pese a Lei nº 9.656/98 não disponha quanto à cobertura de medicamento domiciliar não neoplásicos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde em custear medicamento para tratamento de fibrose pulmonar, especialmente quando não há outro tipo de tratamento indicado para a referida enfermidade. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. NINTEDANIBE. ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA. LEI 14.454/2022. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por operadora de plano de saúde visando afastar a obrigação de custeio do medicamento Nintedanibe, prescrito a beneficiária diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática. A recorrente alega violação aos arts. 10, VI, §§ 1º e 4º, e 12, II, "g", da Lei 9.656/1998 e sustenta a ausência de cobertura contratual por se tratar de medicamento de uso domiciliar não incluído no rol da ANS. O Tribunal de origem reconheceu a excepcionalidade da situação clínica e a necessidade do medicamento para a preservação da vida da paciente, à luz da Lei 14.454/2022. O recurso foi inadmitido com fundamento nos óbices das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS, quando indicado em situação clínica excepcional; (ii) definir se a análise da obrigação de custeio pode ser feita em sede de recurso especial, à luz das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de cobertura de medicamentos fora do rol da ANS em hipóteses excepcionais, quando evidenciada a imprescindibilidade terapêutica,

ausência de substituto eficaz e respaldo técnico por entidades reconhecidas, nos moldes firmados nos EREsp 1.889.704/SP e 1.886.929/SP.

4. A Lei 14.454/2022 incorporou expressamente esses critérios excepcionais à legislação, permitindo o custeio de tratamentos não incluídos no rol da ANS, desde que preenchidos requisitos técnicos objetivos, como eficácia comprovada e recomendação por órgãos como a CONITEC ou entidades internacionais de renome.

5. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão em prova documental que apontava a urgência, necessidade e adequação do medicamento prescrito, bem como o risco de agravamento da doença em caso de negativa de cobertura, o que inviabiliza a reforma do julgado sem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

6. A análise das cláusulas do contrato de plano de saúde, no ponto em que trata da exclusão de medicamentos domiciliares, também encontra vedação na via especial, nos termos da Súmula 5 do STJ.

7. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência dominante do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ, que impede o conhecimento de recurso especial interposto por divergência quando o acórdão recorrido segue entendimento consolidado. IV. DISPOSITIVO

8. Agravo não conhecido.

(AREsp n. 2.804.354/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.) Grifamos

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE.

> **1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o medicamento Nintedanibe (OFEV), deve ser custeado pelo plano de saúde para tratamento de fibrose pulmonar idiopática que acomete o beneficiário - doença degenerativa do pulmão, considerada grave e rara.**
> **2. Não se desconhece que se configura lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim.**
> **3.Obrigatório o fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV) registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente para o tratamento da doença, de modo que se figura abusiva a mera recusa em custear a cobertura, lastreada tão somente na ausência de previsão pela ANS de uso para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática, sem a indicação, em contrapartida, de terapêutica alternativa eficaz e segura para a enfermidade.**
> 4. Recurso especial conhecido e provido.
> (REsp n. 2.211.495/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) Grifamos

No caso dos autos, a documentação acostada à inicial evidencia a necessidade do fornecimento da medicação para tratamento da grave doença em que foi cometida a parte autora, a fim de promover-lhe uma melhor qualidade de vida e saúde.

Além disso, a indicação aos procedimentos é de ordem médica e é o profissional que assiste diretamente o paciente quem detém o conhecimento sobre a necessidade de tratamento das patologias, não cabendo às operadoras de saúde negarem (ou limitarem) a cobertura, sob pena de por em risco a saúde do doente.

Em relação ao dano moral, tenho-o como presente, uma vez que restou incontroverso o fato que o gerou, traduzido na recusa injustificada de tratamento médico à parte autora, ainda mais diante da perspectiva de agravamento da sua saúde.

Inclusive, este é o entendimento jurisprudencial:

> AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM INFLAMAÇÃO RENAL. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. COBRANÇAS DO HOSPITAL À ORA RECORRIDA. PROTESTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
>
> **1. "Conforme o posicionamento desta Corte Superior, o usuário faz jus à indenização por danos morais se o descumprimento contratual, pela operadora de saúde, resultar em negativa indevida de cobertura e, dessa recusa, decorrer agravamento de sua dor, abalo psicológico ou prejuízos para sua saúde debilitada. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.516.223/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 14/6/2024).**
>
> 2. O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 15.000, 00 (quinze mil reais), não é exorbitante nem desproporcional, considerados os danos sofridos pela recorrida que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, suportou cobranças por parte do hospital, inclusive com protesto, após o plano de saúde se negar a pagar pelo tratamento de emergência de sua filha diagnosticada com pielonefrite e dores intensas.
>
> 3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.143.131/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. CIRURGIA REPARADORA. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. RECUSA INJUSTA. DANO MORAL. CABIMENTO. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.
1. [...]
5. A jurisprudência desta Corte Superior Apossui o entendimento de ser cabível indenização por danos morais advindos da injusta recusa de manutenção de cobertura de plano de saúde, visto que o fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. Precedentes.
6. No caso, reverter a conclusão do tribunal de origem para acolher a pretensão recursal demandaria a análise e a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.
7. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
8. Agravo interno não provido.

> (AgInt no AREsp 1782946/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 02/03/2022)

Quanto ao valor do dano, indispensável trazer a colação, ante os parâmetros que apresenta, a lição de Sálvio Figueiredo Teixeira, citado por Maria Celina Bodin de Moraes:

> "Certo que a indenização, como se tem assinalado em diversas oportunidades, deve se fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades em cada caso, devendo, de outro lado, desestimular o ofensor a repetir o ato." (MORAES, Maria Celina Bodin. Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 31.)

À luz, portanto, desses parâmetros condeno a requerida a pagar, a título de danos morais, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, resolvo o mérito da demanda *ex vi* do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e **JULGO PROCEDENTES** os pedidos dispostos na petição inicial para, **confirmando a tutela anteriormente concedida**, condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, pelos **danos morais** sofridos, acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês desde a citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária pelo IPCA a partir da sentença (Súmula 392 STJ).

Condeno-a, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, que deverá ser revertido ao Fundo de Aparelhamento e Modernização da Defensoria Pública Estadual – FADEP.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

São Luís, 1º de agosto de 2025.

Aureliano Coelho Ferreira
Juiz Auxiliar

Assinado eletronicamente por: AURELIANO COELHO FERREIRA 25080717222575800000144893175
07/08/2025 17:22:25
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

IMPRIMIR GERAR PDF